

Urojenia i *halucynacje*

Objawy „dodane” do normalnego doświadczenia. Najlepiej reagują na leczenie. Pomocne jest precyzyjne nazywanie i wymiarowa ocena, nie traktowanie ich jako monolitu.

CZAS: 15 min Psychoedukacja · pierwsze tygodnie

ŹRÓDŁO: Haddock i in. (1999, PSYRATS); Garety & Hemsley (1994); Bentall (2003); Freeman (2002)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się **nazwać typ** swoich objawów (4 typy urojeń, 3 typy halucynacji). W sekcji 3 użyj **wymiarowej oceny** — nie tylko „mam halucynacje”, lecz *jak silne, jak często, jak bardzo bołą, czy wpływają na zachowanie*. Wypełnij dla jednego konkretnego objawu — zabierz na sesję.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klinicysta, który traktuje wszystkie urojenia tak samo, gubi *punkty wejścia*: można pracować nad **dystresem** niezależnie od **przekonania**, nad **preokupacją** osobno. Skala PSYRATS (ang. *Psychotic Symptoms Rating Scales*, Haddock 1999) — używana w badaniach CBTp — pokazała, że pomiar 4 wymiarów daje lepszy plan terapii niż ogólne „złagodzić objawy”. Ważne: halucynacje i urojenia pojawiają się również w PTSD, ciężkiej depresji, manii, deprywacji snu — **nie są patognomoniczne** dla schizofrenii.

01 📋 Halucynacje — doznania bez bodźca

SŁUCHOWE

60–80% przypadków

„Głosy” — najczęstsze. Mogą krytykować, komentować, nakazywać, prowadzić dialog. Czasem szept, czasem krzyk.

Beavan (2011): 5–15% populacji ogólnej doświadcza co najmniej raz w życiu.

WZROKOWE

15–30%

Postacie, cienie, kształty, błyski. Częstsze w psychozach związanych z substancjami, otępieniami, padaczkę skroniowej. Warto wykluczyć przyczynę somatyczną.

INNE

rzadsze

Węchowe (dziwne zapachy), smakowe, dotykowe (czucie na skórze). Często sygnał, że potrzebne pełne badanie somatyczne — wykluczenie chorób mózgu.

02 🕒 Urojenia — cztery główne typy

PRZEŚLADOWCZE

Przekonanie, że ktoś chce skrzywdzić, śledzi, spiskuje. **Najczęstszy typ.** Garety & Freeman (1999): często łączą się z dystresem, izolacją.

ODNOSZĄCE / KSOBNE

„Wszystko jest dla mnie” — reklamy, piosenki w radiu, gesty obcych ludzi zawierają osobiste komunikaty. Mózg wykrywa wzorce, których nie ma.

WIELKOŚCIOWE

Posiadanie nadprzyrodzonych zdolności, misji, tożsamości historycznej. Częste w manii i psychozie maniackalnej. Często mniej dystresu, ale wysokie ryzyko zachowań.

ODDZIAŁYWANIA / WPŁYWU

„Ktoś kontroluje moje myśli”, „moje myśli są transmitowane”, „wkładają mi myśli”. Klasyczne objawy schneiderowskie, częste w schizofrenii.

03 Cztery wymiary oceny każdego objawu

Podejście wymiarowe (PSYRATS, Haddock 1999) — dla *jednego konkretnego objawu* (np. „głos krytykujący”), oceniasz **cztery niezależne wymiary**. CBTp pracuje z każdym z nich osobno.

PRZEKONANIE

ang. conviction

Jak bardzo wierzysz? 0 = nie wierzę, 10 = pełna pewność.

PREOKUPACJA

ang. preoccupation

Ile czasu w ciągu dnia o tym myślisz? 0 = wcale, 10 = ciągle.

DYSTRES

ang. distress

Ile cierpienia sprawia? 0 = nie boli, 10 = nie do zniesienia.

WPŁYW NA ZACHOWANIE

ang. action tendency

Ile zmienia Twoje życie? 0 = wcale, 10 = wszystko.

Klucz CBTp: celem nie zawsze jest *conviction* = 0. Częściej celem jest *distress* = 3 *zamiast* 9 przy tym samym *conviction*. Można żyć dobrze z dziwnym przekonaniem, jeśli ono nie boli i nie steruje zachowaniem.

04 Mój konkretny objaw

Wybierz **jeden objaw**, który Cię najbardziej dotyczy w tym tygodniu. Opisz go precyzyjnie — to baza do rozmowy z terapeutą. Następnie zaznacz cztery wymiary z sekcji 3.

OPIS OBJAWU

— co dokładnie, kiedy, jak długo, jakie wyzwała emocje

PRZEKONANIE

0–10

PREOKUPACJA

0–10

DYSTRES

0–10

WPŁYW NA ŻYCIE

0–10

05 Co realnie pomaga

NAZWANIE I DYSTANS

„Słyszę głos, który mówi X” — zamiast „X jest prawdą”. Nazwanie objawu zmienia jego pozycję — z rzeczywistości na doświadczenie.

ŁAGODNE TESTOWANIE

„Czy istnieje **INNE** wyjaśnienie?” — nie konfrontuj. CBTp pomaga rozwinąć alternatywne hipotezy, sprawdzić je delikatnymi eksperymentami.

SEN I OGRANICZENIE SUBSTANCJI

Brak snu i THC silnie nasilają objawy pozytywne. Regularny rytm 7–9 h + abstynencja od THC = realna redukcja częstotliwości.

FARMAKOTERAPIA

Antypsychotyki pozostaje **filarem** leczenia objawów pozytywnych — meta-analizy wskazują, że redukują częstotliwość i nasilenie u większości pacjentów.

Klucz: objawy pozytywne *najlepiej reagują na leczenie* spośród wszystkich objawów psychozy. Wykes i in. (2008, meta-analiza CBTp): wielkość efektu $d = 0,37$ dla objawów pozytywnych — to znaczy, że *tak*, terapia działa, choć powoli i z indywidualną zmiennością. **Bentall (2003):** w „*Madness Explained*” pokazuje, że urojenia i halucynacje to *kontinuum* z normalnym doświadczeniem — każdy z nas miewa „dziwne myśli” czy słyszy własne imię w tłumie. Różnica jest w **intensywności i wpływie**, nie w naturze.